

Les cancers du sein: G1

FDRs:

1- Facteurs génétiques : ATCD familiaux de kc du sein: Mutation du gène BRCA1 ou BRCA2;sd lynch

2 – Facteurs hormonaux : témoignent de l'imprégnation estrogénique :

- * Ménarches précoces (avant 12 ans)
- * Ménopause tardive (après 55 ans)
- * Age de la première grossesse tardif
- * Femmes nullipares, paucipares.
- * Femme non allaitante
- * Contraception hormonale (type de contraception)
- * THS de la ménopause ???

3 – antécédents pathologiques du sein mastopathies benigne atypique

4- Facteurs environnementaux :

- Obésité +++
- LES ALIMENTS transformés et les antioxydants +++
- alcool
- Irradiation
- Activité physique : rôle protecteur

I- Diagnostic positif :

A – Diagnostic clinique :

1 - Interrogatoire :

- Facteurs de risque majeurs
- Antécédents personnels et familiaux
- Mode d'installation
- L'évolution ...etc.
- Motif de consultation :
 - * Tumeur : +++ 65 – 80 % des cas.
 - * Douleur :
 - * Modifications cutanées :
 - * Écoulement mamelonnaire : UNILATERAL, UNIPORE , et SEROSANGLANT.
 - * Adénopathie (s) axillaire (s)
 - * Gros bras :

2- Examen clinique :

Conditions de l'examen +++++ examen torse nu , demi assise ,et décubitus dorsal

a – L'inspection :

- Modification des contours du sein
- Asymétrie des deux seins , des deux mamelons
- Signes inflammatoires : * Rougeur * Peau d'orange
- Modifications cutanées : * Rétraction, dépression * Ombilication du mamelon * Voussure * Ulcération cutanée * Aspect et coloration de la peau
- Autres signes : * Lésion eczématiforme * Ecchymose * Circulations veineuses superficielles
- Adénopathies axillaires ou sus claviculaires.

b- palpation :

quadrant par quadrant par la pulpe des doigts : siège , taille , consistance : dure ou molle , limites , mobilité par rapport au plan profond et superficiel , * La focalité , Signes inflammatoires : = TRIADE : Rougeur, Chaleur, Douleur ⇒ Tumeurs à croissance rapide. ⇒ Mastite carcinomateuse

- * Sensibilité : Souvent la tumeur n'est pas sensible +++++ si douloureux (il envahit la peau =stade plus prononcer),

Mamelon : ⇒ Écoulement : Uni ou bilatéral uni ou multipore

Aires ganglionnaires : Doit être SYSTEMATIQUE., AXILLAIRES et SUS CLAVICULAIRES , DES DEUX COTES

- * Adénopathies suspectes si : DURE, ASYMETRIQUES, FIXEES et SENSIBLES.

c – Examen général: A la recherche de métastases : Pleuro pulmonaire Hépatiques , Osseuses (Points osseux douloureux ++++), neurologique

-3DAE devant un. Nodule du sein : tumeur bénigne,tumeur maligne,tuberculose

B – Le diagnostic paraclinique :

1-examens radiologiques LA MAMMOGRAPHIE et L'ÉCHOGRAPHIE MAMMAIRE.

1- La mammographie : examen primordial, qui se fait entre J8 et J10 des règles

- réalisé en première intention sauf chez une Femme enceinte et allaitante ou Jeune fille (30 ans) (sein très dense)
- utilisé également dépistage (tumeur infracliniques)
- Face, profil et oblique externe

codification du risque de cancer selon classification ACR 0 à 5

- * ACR 0 ☐ nécessite autres investigations (non concluant)
- * ACR 1 ☐ normal
- * ACR2 ☐ absence de signes de malignité
- * ACR3 ☐ bénin probable mais à surveiller à court terme
- * ACR4 ☐ anomalie suspecte : biopsie s'impose
- * ACR5 ☐ haute probabilité de malignité

Devant ACR2 on évoque :1 kyste 2gg intra mammaire , 3 hamartome

Si macrocalcification -> ACR2

Opacité typiquement SI MALIN

- * Contours irréguliers
- * Stellaire,
- * Spiculée, à centre dense
- * Prolongements opaques , linéaires
- * Taille < la masse palpée.

CLASSIFICATION MORPHOLOGIQUE DES MICROCALCIFICATIONS



Type 1 : micro calcifications annulaires, arciformes ou polyédriques.

Risque de cancer du sein quasi nul.

Type 2 : micro calcifications rondes et de tailles variables.

Risque de carcinome évalué à 22 %.

Type 3 : micro calcifications poussiéreuses pulvérulentes.

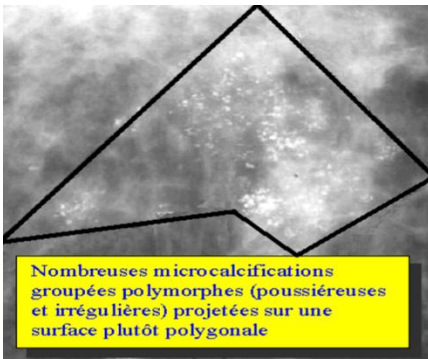
Risque de cancer estimé à 36 %.

Type 4 : micro calcifications irrégulières

Risque de cancer estimé à 56 %.

Type 5 : micro calcifications vermiculaires ou branchées.

Risque de carcinome estimé à 91 %.



Triangle a sommet retro aréolaire = malin

2 - L'échographie mammaire complémentaire à la mammographie surtout si seins denses chez la femme jeune ou enceinte

Le cancer du sein est typiquement : 3 C :

- 1- hypoéchogène,
- 2- contours irréguliers
- 3- cône d'ombre
- 4- grand axe vertical (horizontal = benin)

3 - L'IRM : N'est pas un examen de dépistage (grande valeur prédictive négative)

si mammographie et échographie sont insuffisants, elle a des indications particulières : femme jeune, cancer génétique (BRCA1/2) ou devant un trt conservateur.

II- examens anatomopathologiques

1- examen histologique : 4

- Intérêt :
- * Type histologique de la tumeur
 - * Le grade histologique de la tumeur
 - * Caractère infiltrant ou non de la tumeur
 - * La recherche des récepteurs hormonaux.

2- Examen cytologique: Cytoponction : Ponction à l'aiguille fine (présence ou non cellules malignes)

- Nodule
- adénopathie axillaire ou sus claviculaire palpable.
- liquide d'écoulement mamelonnaire
- Grattage cutanée si maladie de Paget (lésion eczématiforme qui cache un cancer de sein)

Cytoponction n'a de valeur que si positive
 Une cytologie négative n'élimine pas dg cancer
Toujours la confronter aux examens clinique et radiologique

3- autres

-macro biopsie : sous mammographie : microcalcifications

-Examen extemporané : si discordance clinique radio

III- bilan extension

- Radiographie du poumon ++++
- Échographie hépatique ++++
- Scintigraphie osseuse +++

VI - CLASSIFICATIONS : Classification TNM :

1- T – Taille de la tumeur :

T x : Détermination de la tumeur primitive est impossible.

T 0 : Pas de signe de tumeur.

T is : Carcinome in situ (CLIS, CCIS , Maladie de Paget sans tumeur palpable).

2- N: Adénopathies palpables

N x : Appréciation impossible de l'atteinte ganglionnaire.

N 0 : Absence de signes d'envahissement ganglionnaire régional.

N 1 : Ganglions axillaires homolatéraux MOBILES

N 2 : Ganglions axillaires homolatéraux FIXES entre eux ou à d'autres structures.

N 3 : Ganglions sous et sus claviculaires

3- M: métastases

M x : Détermination impossible de l'extension métastatique.

M 0 : Pas de métastases à distance.

M 1 : Métastases à distance

VII – DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : +++++

A – Les tumeurs bénignes :

1- Adénofibromes :

Plus fréquentes. - Femme JEUNE

Clinique : Tumeur arrondie , ovoïde , mobile, ferme et **Sans adénopathies**

Mammo + écho : opacité homogène, régulière, axe horizontal, .

Attention cancer médullaire

Histologie : Prolifération bénigne à double composante épithéliale et conjonctive.

2- Tumeurs phyllodes :

Clinique :Tumeurs volumineuses, ovalaires à croissance RAPIDE, parfois **polylobée**, de consistance molle

Mammo + écho :polycyclique , à contours réguliers et bien limités.

Risque de formes sarcomateuses +++(grade 3)

3- Dystrophie fibrokystique du sein = Terrain d'hyperoestrogénie

Clinique : Mastodynies + Seins durs avec des masses palpables, sensibles, consistance élastique et d'aspect kystique.

B - Tuberculose mammaire : (Dgc diff avec ACR5)

Clinique : Tumeur mal limitée abcès froid , Histologie : +++++.

C - Abscess du sein :

Surtout en cas de cancer inflammatoire (T4D) d'où l'intérêt de biopsie après drainage d'un abcès

IX – Les facteurs pronostiques : +++++

1 - La taille tumorale : petite taille = moins de métastases

2 – Le statut ganglionnaire :

- * Nombre de ganglions envahis

- * Rupture capsulaire

- * Envahissement sus claviculaire

3 – Le grading d'histopronostic : ++++ = (SBR) Classée de I , II et III.

Grade I : Bon pronostic ⇒ Peu évolutive

Grade III : Métastases rapides

4 – Les récepteurs hormonaux : +++ : Récepteurs à l'œstrogène (RO) à la progestérone (RP) => facteur prédictif de réponse à hormonothérapie

5- facteur de prolifération : ki67

6 -La surexpression de HER2:

X- Les moyens thérapeutiques : +++

1) La chirurgie : vise à retirer la tumeur et les adénopathies axillaires envahies.

- Traitement radical ou conservateur.

a - Traitement radical : mastectomie associé à un Curage axillaire homolatérale = Intervention de type Patey : ++++

b – Traitement conservateur : de la glande mammaire tout en enlevant la tumeur avec des marges de sécurité = ASSOCIE A UN CURAGE AXILLAIRE

Ganglion sentinelle = 1^{er} ganglion atteint

Deux méthodes : Colorimétriques ou Isotopes . -> Si négatif : pas de curage pour éviter les complications du curage

Les indications sont précises: Petite tumeur < 3cm +Pas d'adénopathies clinique + pas de préjudice esthétique avec une radiothérapie systématique

2 - La radiothérapie :pour éviter les récidives locales en complément avec la chirurgie

3 -La chimiothérapie : Adjuvante ou néoadjuvante.

- Intérêt * Éviter les métastases chez les patientes à RISQUE

* Stériliser les micro foyers métastatiques

4 -L'hormonothérapie : Blocage de la fonction ovarienne ⇒ Castration : ++++

- Chirurgicale
- Radiothérapie
- Analogues de la LH-RH
- Anti-oestrogènes ++++
- Inhibiteurs de l'aromatase ++++

5- *Herceptin* =anti HER2

XII – SURVEILLANCE : ++++

- CLINIQUE ++++ : 3 fois la première année puis chaque 6 mois une fois /an à partir de 5 ans.

- Radiologique : * Une mammographie par an ; les 5 premières années.

* Puis une mammographie / 2 – 3 ans.

- Biologique : CA 15-3 / 6 mois.